PEMBARUAN DESAIN UI/UX WEBSITE SILOBA DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Oleh:

DANIEL BERGAS PRASETYO

NPM. 21081010167

DZIKRA FADHILA ABRAR S.

NPM. 21081010177

MUHAMMAD AHSANUR RAFI

NPM. 21081010305

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2025

LEMBAR PENGESAHAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Judul	**: PEMBARUAN DESAIN UI/UX WEBSITE SILOBA DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**
Oleh	**: Daniel Bergas Prasetyo, Dzikra Fadhila Abrar Setiawan, Muhammad Ahsanur Rafi**
NPM	**: 21081010167, 21081010177, 21081010305**

Telah Diseminarkan Dalam Ujian PKL, pada :
Hari Kamis, Tanggal 16 Januari 2024

Menyetujui

Nama	Tanda Tangan
Pembimbing Lapangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur **Santi Pramaswari, S.Si, Apt.** **NIP 19780118 200212 2 006**	.....
Dosen Pembimbing **Fetty Tri Anggraeny, S.Kom., M.Kom** **NIP 19820211 202121 2 005**	.....
Dosen Penguji **Budi Mukhamad Mulyo,S.Kom.,M.T.** **NIP 19891118 202406 1 003**	.....

Mengetahui

Dekan **Fakultas Ilmu Komputer**	**Koordinator Program Studi** **Informatika**
Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, M.T.	**Fetty Tri Anggraeny, S.Kom., M.Kom**
NIP 19681126 199403 2 001	**NIP 19820211 202121 2 005**

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daniel Bergas Prasetyo
NPM : 21081010167

Nama : Dzikra Fadhila Abrar Setiawan
NPM : 21081010177

Nama : Muhammad Ahsanur Rafi
NPM : 21081010305

Menyatakan bahwa kegiatan PKL yang kami lakukan memang benar-benar telah kami lakukan di perusahaan :

Nama Perusahaan : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.118, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya.

Valid, dan perusahaan tempat kami PKL benar adanya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jika kami menyalahi surat pernyataan yang kami buat maka kami siap mendapatkan konsekuensi akademik maupun non-akademik. Berikut surat pernyataan kami buat sebagai syarat laporan PKL di Prodi Informatika, FIK, UPN "Veteran" Jawa Timur.

Hormat Kami,



Daniel Bergas Prasetyo

21081010167



Dzikra Fadhila A.S.

21081010177



Muhammad Ahsanur R.

21081010305

ii

SURAT KETERANGAN SELESAI PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. A. Yani No.118 Telp. (031) 8280910 Fax. (031) 8290423 Kode Pos 60231
website : http://dinkes.jatimprov.go.id email : ppid@dinkes.jatimprov.go.id
SURABAYA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 442/22333/102.5/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono., Sp.PD., KPTI.,FINASIM
NIP	:	19690420 200501 1 009
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa berikut :

Nama	:	Daniel Bergas Prasetyo
NIM	:	121081010167
Fakultas	:	Ilmu Komputer
Juruan	:	Informatika
Universitas	:	Universitas Pembangunan Nasional (Veteran)
Penempatan Magang	:	Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Telah secara nyata melaksanakan Kegiatan Magang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mulai tanggal **08 Juli s/d 08 Agustus 2024**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KESEHATAN

Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA TRIYONO., Sp.PD., KPTI., FINASIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690420 200501 1 009

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. A. Yani No.118 Telp. (031) 8280910 Fax. (031) 8290423 Kode Pos 60231
website : http://dinkes.jatimprov.go.id email : ppid@dinkes.jatimprov.go.id
SURABAYA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 442/22334/102.5/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Prof. Dr. Erwin Astha Triyono, Dr., Sp.PD., KPTI.,FINASIM
NIP	:	19690420 200501 1 009
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa berikut :

Nama	:	Dzikra Fadhila Abrar Setiawan
NIM	:	121081010177
Fakultas	:	Ilmu Komputer
Juruan	:	Informatika
Universitas	:	Universitas Pembangunan Nasional (Veteran)
Penempatan Magang	:	Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Telah secara nyata melaksanakan Kegiatan Magang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mulai tanggal **08 Juli s/d 08 Agustus 2024**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA TRIYONO., Sp.PD., KPTI., FINASIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690420 200501 1 009

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. A. Yani No.118 Telp. (031) 8280910 Fax. (031) 8290423 Kode Pos 60231
website : http://dinkes.jatimprov.go.id email : ppid@dinkes.jatimprov.go.id
SURABAYA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 442/22335/102.5/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Prof. Dr. Erwin Astha Triyono, Dr., Sp.PD., KPTI.,FINASIM
NIP	:	19690420 200501 1 009
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa berikut :

Nama	:	Muhamad Ahsanur Rafi
NIM	:	121081010305
Fakultas	:	Ilmu Komputer
Juruan	:	Informatika
Universitas	:	Universitas Pembangunan Nasional (Veteran)
Penempatan Magang	:	Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat

Telah secara nyata melaksanakan Kegiatan Magang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mulai tanggal **08 Juli s/d 08 Agustus 2024**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA TRIYONO., Sp.PD., KPTI., FINASIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690420 200501 1 009

Judul	:	Pembaruan Desain UI/UX Website SILOBA
Studi Kasus	:	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Penulis	:	Daniel Bergas Prasetyo, Dzikra Fadhila Abrar Setiawan, Muhammad Ahsanur Rafi
Pembimbing	:	Fetty Tri Anggraeny, S.Kom., M.Kom.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan data kesehatan. Website SILOBA (Sistem Informasi Alokasi Obat) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu sarana penting untuk mendukung distribusi obat secara efektif. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa desain antarmuka *website* ini belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pengguna, seperti kesulitan navigasi, informasi yang tidak terstruktur, serta kurangnya responsivitas antarmuka.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembaruan desain UI/UX *website* SILOBA guna meningkatkan pengalaman pengguna serta efisiensi sistem. Dalam proses ini, pendekatan *user-centered design* diterapkan dengan melibatkan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan utama. Desain baru dikembangkan menggunakan Figma, yang memungkinkan perancangan prototipe interaktif dengan tata letak yang lebih terorganisir, fitur navigasi yang intuitif, dan penyajian informasi yang lebih jelas. Prototipe diuji melalui beberapa iterasi untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna.

Hasil pembaruan menunjukkan peningkatan signifikan dalam *aksesibilitas* dan efisiensi penggunaan sistem. *Website* SILOBA versi baru ini diharapkan dapat mendukung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam memberikan layanan yang lebih efektif kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan alokasi obat.

***Kata kunci**: UI/UX, SILOBA, Sistem Informasi Alokasi Obat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Website.*

Judul	:	Pembaruan Desain UI/UX Website SILOBA
Studi Kasus	:	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Penulis	:	Daniel Bergas Prasetyo, Dzikra Fadhila Abrar Setiawan, Muhammad Ahsanur Rafi
Pembimbing	:	Fetty Tri Anggraeny, S.Kom., M.Kom.

Abstract

The development of information technology provides significant opportunities to improve public services, including in the management of health data. The SILOBA website (Sistem Informasi Alokasi Obat), managed by the East Java Provincial Health Office, serves as an essential platform to support effective drug distribution. However, evaluations reveal that the website's interface design is not yet optimal in meeting user needs, such as navigation difficulties, unstructured information, and a lack of responsive interface features.

This study aims to redesign the UI/UX of the SILOBA website to enhance user experience and system efficiency. A user-centered design approach was adopted, involving users to identify their primary needs. The new design was developed using Figma, enabling the creation of interactive prototypes with a more organized layout, intuitive navigation features, and clearer information presentation. The prototypes underwent several iterations to ensure alignment with user requirements.

The updated design demonstrates significant improvements in accessibility and system usability. The new version of the SILOBA website is expected to assist the East Java Provincial Health Office in providing more effective services to the public, particularly in managing drug allocation.

***Keywords**: UI/UX, SILOBA, Drug Allocation Information System, East Java Provincial Health Office, Website.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang yang berjudul "Pembaruan Desain UI/UX *Website* SILOBA di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur". Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang telah kami jalani di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan Praktek Kerja Lapangan:

1. Orang tua, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam segala keadaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Fetty Tri Anggraeny, S.Kom, M.Kom. selaku Koordinator Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus dosen pembimbing penulis pada program Magang Mandiri, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang berharga.
4. Bapak M. Muharrom Al Haromainy, S.Kom., M.Kom. selaku koordinator Magang dan Studi Independen Bersertifikat yang membantu dalam proses administrasi dan penyaluran informasi terkait Praktek Kerja Lapangan.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang telah memberikan kesempatan dan wadah bagi penulis untuk mengembangkan keterampilan dan mengimplementasikan pengetahuan melalui kegiatan magang mandiri.
6. Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.Pd, K-PTI., FINASIM selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

7. Para Pembimbing Lapangan, yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan, memastikan penulis dapat menyelesaikan program ini dengan baik.
8. Teman-teman dan seluruh peserta Program Magang Mandiri, yang bersama-sama berjuang memberikan dukungan selama magang.

Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan menjadi referensi yang bernilai. Dengan demikian, kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 30 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN..... i

SURAT PERNYATAAN..... ii

SURAT KETERANGAN SELESAI PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....iii

ABSTRAK..... vi

ABSTRACT.....vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR GAMBAR..... xii

DAFTAR TABEL..... xiii

DAFTAR LAMPIRAN..... xiv

BAB I..... 1

PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Rumusan Masalah.....2

1.3. Tujuan Praktik Kerja Lapangan..... 2

1.3.1. Tujuan Umum..... 2

1.3.2. Tujuan Khusus.....3

1.4. Manfaat dan Kegunaan..... 3

BAB II..... 4

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL.....4

2.1. Sejarah Perusahaan/Instansi..... 4

2.2. Struktur Organisasi.....5

2.3. Bidang Usaha.....7

BAB III.....9

PELAKSANAAN..... 9

3.1. Waktu dan Tempat PKL.....9

3.2. Tinjauan Pustaka.....9

3.2.1. Pengertian Sistem Informasi..... 10

3.2.2. Use Case Diagram..... 10
3.2.3. Desain Antarmuka Pengguna (UI) dan Pengalaman Pengguna (UX) 11
3.2.4. Figma.....12
3.2.5. Low-Fidelity (Lo-Fi) Prototype..... 13
3.2.6. High-Fidelity (Hi-Fi) Prototype..... 14
3.3. Pelaksanaan PKL.....15
3.3.1. Log Activity..... 16
BAB IV..... 25
HASIL DAN PEMBAHASAN..... 25
4.1. Hasil.....25
4.2. Desain Sebelum Pembaruan.....27
4.2.1. Halaman Awal.....27
4.2.3. Halaman Menu Alokasi Obat.....28
4.2.4. Halaman Layanan Permintaan Obat..... 29
4.2.5. Halaman Booking Antrian Pengambilan.....29
4.3. Use Case Diagram..... 29
4.4. Hasil Desain Dan Alur Proses Penggunaan.....34
4.2.6. Halaman Awal.....36
4.2.7. Halaman User.....38
4.2.8. Halaman Admin..... 43
4.5. Pembahasan..... 48
BAB V.....50
PENUTUP.....50
5.1. Kesimpulan.....50
5.2. Saran..... 50
DAFTAR PUSTAKA.....52
LAMPIRAN.....53
1. Dokumentasi Kegiatan..... 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....5
Gambar 3.1 Logo Figma..... 12
Gambar 4.2 Halaman Login Sebelum Pembaruan..... 28
Gambar 4.6 Use Case Diagram Pengguna..... 30
Gambar 4.7 Use Case Diagram Admin.....32
Gambar 4.8 Activity Diagram..... 34
Gambar 4.9 Tampilan Figma Halaman Awal.....36
Gambar 4.10 Tampilan Figma Halaman Login.....37
Gambar 4.11 Tampilan Figma Halaman Alokasi Obat..... 38
Gambar 4.12 Tampilan Figma Halaman Permintaan Obat..... 39
Gambar 4.14 Tampilan Figma Halaman Riwayat Permintaan Obat.....40
Gambar 4.13 Tampilan Figma Halaman Pengambilan Obat.....41
Gambar 4.15 Tampilan Figma Halaman Riwayat Pengambilan Obat..... 42
Gambar 4.16 Tampilan Figma Halaman Input Alokasi Obat.....43
Gambar 4.17 Tampilan Figma Manajemen Alokasi Obat.....44
Gambar 4.18 Tampilan Figma Riwayat Permintaan Obat..... 45
Gambar 4.19 Tampilan Figma Riwayat Pengambilan Obat.....47

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Logbook Kegiatan..... 16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan..... 53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era digital yang berkembang pesat, kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin vital. Salah satu implementasi teknologi ini adalah pembuatan *website* yang berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, dan manajemen data. *Website* tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh organisasi pemerintah untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola distribusi obat-obatan untuk memastikan ketersediaan dan ketepatan alokasi di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, proses ini sering menghadapi tantangan dalam hal pendataan, pemantauan, dan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang mampu mendukung proses tersebut secara efektif dan efisien.

SILOBA (Sistem Informasi Alokasi Obat) hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis web, SILOBA dirancang untuk menyediakan platform digital yang memudahkan seluruh tahapan proses distribusi obat, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengelolaan data stok, pengiriman obat, hingga pelaporan distribusi secara otomatis. Alur distribusi obat dimulai dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan kota/kabupaten, sehingga memastikan ketersediaan obat yang merata di setiap wilayah. Fokus utama dari pengembangan sistem ini adalah pada perancangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang *user-friendly* dan *responsif*, sehingga dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi berbagai pihak yang terlibat. Proyek ini diawali dengan analisis kebutuhan pengguna, di mana ditemukan bahwa desain sebelumnya memiliki beberapa keterbatasan, seperti navigasi yang kurang *intuitif* dan penyajian informasi yang kurang terstruktur. Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan berbasis studi kasus

digunakan dalam perancangan desain baru, sehingga hasilnya dapat lebih relevan dengan kebutuhan pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk memperbarui desain UI/UX dari aplikasi SILOBA berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Sebelumnya, aplikasi SILOBA menghadapi beberapa kendala yang signifikan, seperti ketergantungan pengguna pada aplikasi eksternal, seperti *WhatsApp*, untuk berkomunikasi dan mendistribusikan informasi, sehingga mengurangi efisiensi sistem. Selain itu, antarmuka pengguna (UI) dinilai kurang rapi dan tidak intuitif, menyebabkan pengalaman pengguna (UX) yang kurang optimal baik bagi pengguna umum maupun administrator. Dengan menerapkan metode agile dalam proses pengembangan, diharapkan aplikasi ini dapat terus disesuaikan dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas dan kredibilitas manajemen distribusi obat, serta mendukung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam menghadirkan solusi teknologi yang inovatif dan efektif.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang desain antarmuka (UI) menggunakan Figma yang lebih sederhana dan efisien untuk meningkatkan kemudahan akses dan pengalaman pengguna pada *website* SILOBA?
2. Bagaimana mengoptimalkan desain fitur-fitur yang ada pada *website* SILOBA agar lebih otomatis dan mampu mendukung proses pelayanan serta pengelolaan data kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh pada saat perkuliahan dan turut berpartisipasi dalam pengembangan *website*.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengimplementasikan *skill* serta ilmu pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan.
2. Untuk menambah pengalaman serta pengetahuan selama menjalani praktik kerja lapangan.

1.4. Manfaat dan Kegunaan

1.4.1. Bagi Penulis

Mahasiswa memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk melaksanakan tugas-tugas di perusahaan. Selama PKL, mahasiswa mendapatkan pengalaman yang langsung dan menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam dunia kerja. Selain itu, PKL membantu mahasiswa mengembangkan rasa tanggung jawab profesionalitas dalam diri mereka.

1.4.2. Bagi Perusahaan

Perusahan atau instansi dapat menerima masukan dan pertimbangan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas operasional mereka. Selain itu, instansi juga mendapatkan dukungan dari mahasiswa yang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), yang turut membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas. Hasil dari PKL juga dapat dimanfaatkan oleh instansi untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi operasional mereka.

1.4.3. Bagi Universitas

Universitas dapat membangun kerja sama dengan dunia kerja dan perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan PKL dapat meningkatkan kesadaran akademik di tengah-tengah dunia kerja. Kegiatan PKL ini juga diharapkan bermanfaat bagi perkembangan akademik di universitas, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya.

BAB II
GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Sejarah Perusahaan/Instansi

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan layanan kesehatan di wilayah Jawa Timur. Keberadaannya berakar dari masa kolonial Hindia Belanda, ketika pelayanan kesehatan diatur melalui institusi *Dienst der Volksgezondheid*. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, lembaga ini bertransformasi menjadi bagian dari sistem pemerintahan nasional, dengan tugas utama meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui berbagai program pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

Pada masa awal kemerdekaan, Dinas Kesehatan Jawa Timur memfokuskan upayanya pada pemberantasan penyakit menular seperti malaria, kolera, tuberkulosis, dan penyakit lainnya yang menjadi ancaman besar bagi masyarakat. Keterbatasan fasilitas kesehatan pada masa itu tidak menghalangi langkah untuk terus memperluas jangkauan layanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas dan pelaksanaan imunisasi massal. Program-program ini menjadi tonggak awal dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah Jawa Timur.

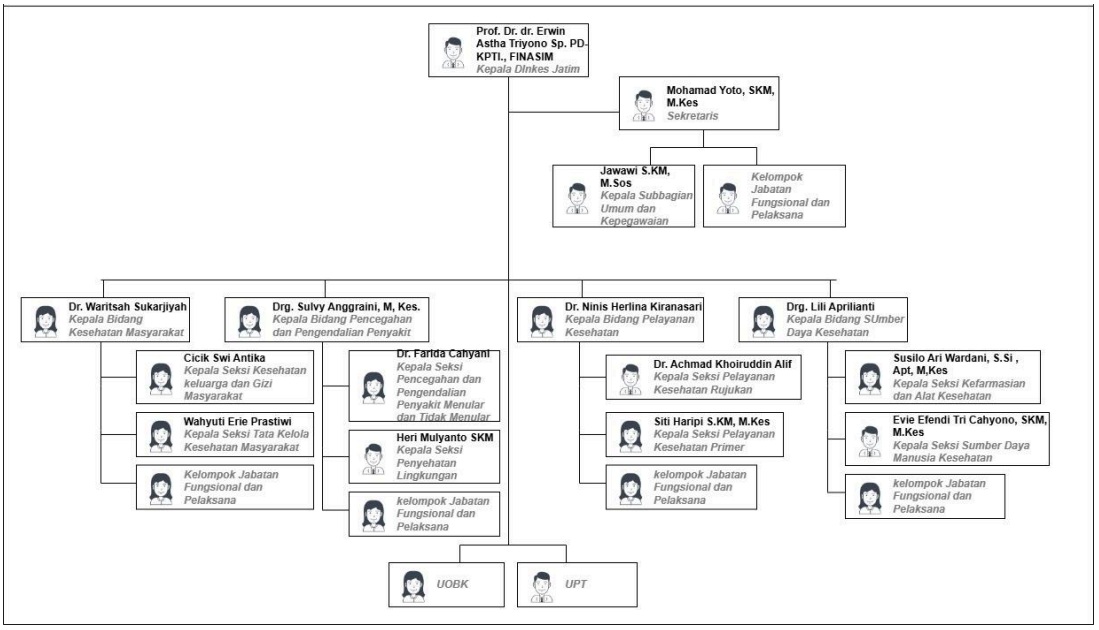
Seiring berjalannya waktu, Dinas Kesehatan Jawa Timur berkembang dengan memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan, baik melalui penyediaan infrastruktur seperti rumah sakit dan klinik, maupun melalui inovasi kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas layanan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, Dinas Kesehatan memiliki peran penting sebagai koordinator pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota, memastikan program kesehatan provinsi terintegrasi dengan kebutuhan daerah.

Hingga saat ini, di bawah kepemimpinan Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM., Dinas Kesehatan Jawa Timur terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program strategis,

seperti pengendalian penyakit tidak menular, promosi kesehatan, serta pengembangan layanan berbasis teknologi. Dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif, Dinas Kesehatan Jawa Timur tetap menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia.

2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah salah satu unit pelaksana pemerintahan di bidang kesehatan. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Timur. Berikut adalah gambaran struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Berikut adalah gambaran struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, serta Sub Bagian Keuangan. Tugasnya meliputi

perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang ini mencakup Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga. Tugas utamanya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional serta mengoordinasikan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Terdiri dari Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, serta Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Bidang ini bertugas merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan terkait surveilans, imunisasi, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang ini meliputi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, serta Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional. Tugasnya mencakup perumusan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi kebijakan pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu lintas, jaminan kesehatan, serta tanggap bencana di bidang kesehatan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang ini mencakup Seksi Kefarmasian, Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga, serta Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Tugasnya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional terkait kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pengelolaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan penyakit tertentu, pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan tenaga kesehatan, dan pendidikan khusus. UPT terdiri atas Kepala dan Kepala Tata Usaha (KTU). Beberapa UPT yang berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur antara lain:

a. Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
b. Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
c. Rumah Sakit Kusta Kediri
d. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
e. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
f. Rumah Sakit Paru Surabaya
g. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
h. Rumah Sakit Paru Jember
i. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
j. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati
k. Laboratorium Herbal Materia Medica Batu
l. Akademi Gizi Surabaya.

2.3. Bidang Usaha

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki bidang usaha utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai program dan layanan yang terintegrasi. Bidang usaha ini meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk masyarakat, dengan fokus pada pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan gizi, serta penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Selain itu, Dinas Kesehatan juga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan, memastikan kepatuhan terhadap standar mutu pelayanan, serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium.

Pengelolaan data dan informasi kesehatan juga menjadi salah satu bidang usaha yang krusial, dengan mengembangkan sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dinas ini juga berperan dalam meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta mengelola pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana kesehatan, termasuk obat-obatan dan alat kesehatan. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada program kesehatan ibu, anak, dan remaja, seperti layanan kesehatan reproduksi, imunisasi, dan pencegahan stunting.

Dalam upaya mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional. Penanganan krisis kesehatan, seperti wabah penyakit dan bencana, juga menjadi prioritas, dengan layanan kesehatan darurat yang cepat dan terkoordinasi. Melalui bidang usaha ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

BAB III
PELAKSANAAN

3.1. Waktu dan Tempat PKL

Kegiatan Praktik Kerja Langsung (PKL) berlangsung selama satu bulan terhitung mulai tanggal 08 Juli hingga 08 Agustus 2024. Selama periode ini, kegiatan PKL dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat. Metode pelaksanaan PKL ini dilakukan secara luring dimulai dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur beralamat di Jl. Ahmad Yani No.118, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya

Selama kegiatan PKL, kami berperan sebagai UI/UX *Designer* dari *website* SILOBA dan kami mengikuti berbagai rangkaian acara yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Hal ini memberikan peserta PKL mendapatkan pengalaman kerja yang komprehensif memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan rekan-rekan kerja dan supervisor, serta mengakses fasilitas kampus yang mendukung proses belajar dan bekerja. Dalam proyek ini, kami mengembangkan pembaruan desain *website* dari SILOBA yang berguna untuk mengalokasikan obat ke berbagai wilayah kota/kabupaten di Jawa Timur.

Dengan jadwal yang terstruktur, kegiatan PKL di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu memberikan pengalaman berharga bagi para peserta. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerapkan pengetahuan teori yang telah mereka pelajari di perkuliahan ke dalam praktik nyata di lingkungan kerja. Pengalaman tersebut tidak hanya memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga menjadi nilai tambah yang signifikan bagi mereka saat mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di masa mendatang.

3.2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menyediakan dasar teori yang solid, menghubungkan proyek dengan penelitian dan konsep yang sudah diterima di bidang UI/UX dan

sistem informasi berbasis *website*. Melalui tinjauan pustaka, penulis dapat mengidentifikasi tren terkini, praktik terbaik dalam desain UI/UX, serta penerapan teknologi berbasis *website* dalam pengembangan sistem informasi. Selain itu, tinjauan pustaka membantu memahami tantangan dan solusi yang telah diidentifikasi oleh peneliti sebelumnya, sehingga proyek dapat menangani masalah dengan cara yang lebih efektif. Dengan mengkaji literatur yang relevan, laporan ini tidak hanya memperkuat validasi dan kredibilitas proyek, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana desain UI/UX yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas sistem uji kompetensi berbasis website.

3.2.1. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan gabungan antara teknologi informasi dan aktivitas manusia yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung operasional dan manajemen. Sistem ini juga terdiri dari kombinasi yang terorganisasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta sumber daya data yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Fungsinya adalah untuk membantu pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, serta penyajian informasi secara visual dalam organisasi.

3.2.2. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang berfungsi untuk memvisualisasikan interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem (Hutauruk, 2019). Diagram ini menggambarkan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem sekaligus cara pengguna berinteraksi dengan fungsi tersebut. Elemen utama dalam *Use Case* Diagram mencakup aktor, yang dapat berupa individu, organisasi, atau sistem lain; *Use Case*, yang merepresentasikan fungsi atau layanan sistem; batas sistem, yang membedakan antara elemen internal dan eksternal sistem; serta asosiasi, yang menghubungkan aktor

dengan *Use Case*. Hubungan antar *Use Case* juga dapat digambarkan menggunakan relasi seperti *include*, *extend*, dan *generalization*. *Use Case Diagram* berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan, mendokumentasikan kebutuhan fungsional, membantu dalam perencanaan dan desain sistem, serta memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2.3. Desain Antarmuka Pengguna (UI) dan Pengalaman Pengguna (UX)

Desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) merupakan aspek penting dalam pengembangan aplikasi mobile modern. UI berfokus pada elemen visual, tata letak, dan interaksi langsung antara pengguna dan aplikasi, sedangkan UX mencakup keseluruhan pengalaman pengguna, mulai dari interaksi awal hingga pencapaian tujuan mereka. Desain UI/UX yang optimal membuat aplikasi menjadi lebih intuitif, mudah digunakan, dan menarik, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Ketika desain ini berhasil diterapkan, pengguna cenderung membuat lebih sedikit kesalahan, merasa puas, dan dapat menggunakan aplikasi dengan lebih efisien.

Proses pengembangan desain UI/UX diawali dengan penelitian mendalam untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna potensial. Langkah berikutnya adalah pembuatan *wireframe*, yaitu sketsa kasar yang menggambarkan tata letak dan struktur aplikasi. Setelah itu, *prototype* interaktif dikembangkan untuk menguji fungsi dan alur pengguna secara awal. Pengujian dengan pengguna nyata menjadi tahap penting untuk memperoleh umpan balik langsung mengenai kinerja dan kegunaan aplikasi, yang kemudian digunakan untuk memperbaiki desain melalui iterasi yang berkelanjutan.

Dengan mengedepankan desain UI yang menarik dan UX yang memberikan kenyamanan, pengembang dapat meningkatkan penerimaan aplikasi di pasar. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan

pengguna, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan dan adopsi aplikasi secara luas.

3.2.4. Figma



Gambar 3.1 Logo Figma

Figma adalah alat desain berbasis web yang memungkinkan kolaborasi secara langsung di antara desainer dan tim produk. Diluncurkan pada tahun 2016, Figma telah menjadi salah satu alat desain UI/UX yang paling populer berkat fitur-fitur inovatifnya yang mendukung proses desain secara kolaboratif dan efisien. Berbeda dengan banyak alat desain lainnya yang memerlukan instalasi perangkat lunak, Figma sepenuhnya beroperasi melalui *browser*.

Salah satu keunggulan utama Figma adalah kemampuan kolaborasi real-time, di mana beberapa pengguna dapat bekerja pada desain yang sama secara bersamaan. Fitur ini mirip dengan *Google Docs*, di mana perubahan yang dilakukan oleh satu pengguna langsung terlihat oleh pengguna lain (Jean Sundego, 2023). Kemampuan ini mempermudah tim desain untuk berkolaborasi tanpa perlu berbagi file secara manual atau mengalami masalah dengan versi dokumen yang berbeda.

Figma menyediakan berbagai alat desain yang intuitif dan kuat, termasuk alat vektor untuk menggambar dan mengedit bentuk, alat teks yang fleksibel, serta fitur *auto-layout* yang memungkinkan elemen desain menyesuaikan tata letaknya secara otomatis sesuai dengan perubahan isi atau ukuran layar. Dengan fitur *prototyping* bawaan, desainer dapat membuat interaksi dan animasi serta mengujinya langsung di dalam platform, tanpa harus berpindah ke alat lain.

Selain itu, Figma mendukung integrasi dengan berbagai plugin dan alat lain untuk memperluas fungsionalitasnya. Misalnya, plugin untuk pengujian kegunaan, manajemen aset desain, atau alat pengembang dapat dihubungkan langsung ke Figma, sehingga alur kerja menjadi lebih efisien dan konsisten. Fitur version history memungkinkan pengguna melihat dan mengembalikan versi sebelumnya dari desain mereka, yang berguna untuk melacak perubahan atau memulihkan pekerjaan jika terjadi kesalahan. Figma Mirror, fitur tambahan lainnya, memungkinkan desainer mempratinjau desain mereka di perangkat seluler untuk memastikan desain responsif dan sesuai tampilan yang diinginkan.

Sejak pertama kali dirilis, Figma terus berkembang dengan pembaruan rutin dan fitur-fitur baru. Komunitas pengguna yang aktif turut mendukung ekosistem Figma melalui berbagi template, plugin, dan sumber daya desain. Dokumentasi lengkap dan berbagai tutorial juga memudahkan pengguna baru untuk memahami dan mengoptimalkan penggunaan alat ini.

3.2.5. *Low-Fidelity (Lo-Fi) Prototype*

Low-Fidelity Prototype adalah representasi yang sederhana dan dasar dari sebuah produk atau desain (Pratama, 2023). Prototipe ini sering digunakan pada tahap awal pengembangan untuk menguji konsep, memperoleh umpan balik dari pengguna, dan mengidentifikasi masalah utama sebelum melanjutkan ke pengembangan yang lebih rinci. Prototipe ini biasanya dibuat dengan cara yang sederhana, menggunakan bahan seperti kertas, pensil, atau alat digital dasar seperti *wireframing tools*. Karena tidak mengandung detail visual atau interaktivitas yang kompleks, pembuatan *low-fidelity prototype* menjadi lebih cepat, murah, dan mudah. Hal ini memungkinkan tim untuk bereksperimen dengan berbagai ide dan memperoleh umpan balik dengan cepat tanpa memerlukan investasi yang besar. Fokus utama dari *low-fidelity prototype* adalah pada struktur dasar dan alur kerja aplikasi atau sistem, bukan pada tampilan dan fungsi detail. Tujuannya adalah untuk menggambarkan tata letak dan navigasi utama.

Biasanya, prototipe ini tidak bersifat interaktif atau hanya memiliki interaktivitas dasar untuk menggambarkan transisi antar layar atau halaman. Dengan cara ini, tim pengembang dapat memvalidasi konsep dengan efisien sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan yang lebih mendalam dan lebih intensif.

3.2.6. *High-Fidelity (Hi-Fi) Prototype*

High-Fidelity Prototype adalah representasi interaktif yang sangat mendetail dari aplikasi atau sistem, yang hampir identik dengan produk akhir dalam hal tampilan, fungsionalitas, dan interaktivitas. Berbeda dengan *low-fidelity prototype*, *high-fidelity prototype* mencakup elemen visual yang kaya seperti warna, tipografi, gambar, dan ikon yang akan digunakan dalam produk final. Selain itu, prototipe ini juga mengintegrasikan interaksi yang lebih kompleks, seperti transisi halaman, animasi, dan respons terhadap input pengguna, sehingga memberikan pengalaman yang sangat mirip dengan aplikasi atau sistem yang sesungguhnya (Prasetyo, 2021). Prototipe ini umumnya dibuat menggunakan alat desain dan prototyping canggih seperti Figma, Sketch, Adobe XD, atau InVision, yang memungkinkan desainer untuk membuat simulasi yang sangat realistis dari produk akhir.

Tujuan utama dari *high-fidelity prototype* adalah untuk menguji dan memvalidasi desain secara detail sebelum memasuki tahap pengembangan yang lebih mahal dan memakan waktu. Prototipe ini memungkinkan tim untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah terkait desain, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna (UX) dengan lebih akurat. Umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan pada tahap ini sangat penting, karena mereka dapat memberikan masukan yang lebih terperinci berdasarkan pengalaman interaktif yang hampir nyata. *High-fidelity prototype* juga sangat berguna untuk menyampaikan visi produk secara lebih jelas kepada tim pengembang, memastikan tidak ada kesalahpahaman mengenai bagaimana aplikasi atau sistem harus berfungsi dan tampil.

Selain untuk pengujian pengguna dan validasi desain, prototipe ini juga berperan sebagai alat penting dalam proses pengembangan. Pengembang dapat menggunakan high-fidelity prototype sebagai panduan rinci dalam membangun fitur dan elemen visual yang akurat, mengurangi kemungkinan iterasi ulang akibat kesalahan desain. Prototipe ini juga sering digunakan dalam presentasi kepada pemangku kepentingan atau klien untuk menunjukkan bagaimana produk akhir akan berfungsi dan terlihat, memberikan mereka kepercayaan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana.

Pembuatan *high-fidelity prototype* memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya dibandingkan dengan *low-fidelity prototype*, karena memerlukan tingkat detail dan presisi yang lebih tinggi. Namun, investasi ini sangat berharga karena dapat mengurangi risiko dan biaya perubahan desain pada tahap pengembangan dan pasca-pengembangan. Dengan demikian, *high-fidelity prototype* menjadi alat penting dalam siklus pengembangan produk, membantu menjembatani kesenjangan antara visi desain dan realitas teknis, serta memastikan produk akhir memenuhi ekspektasi pengguna dan standar kualitas yang diinginkan.

3.3. Pelaksanaan PKL

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berlangsung selama 1 (satu) bulan dengan fokus pada pembaruan desain UI/UX website SILOBA. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, mahasiswa berperan dalam proses analisis kebutuhan, perancangan desain antarmuka, hingga implementasi prototipe menggunakan alat bantu desain seperti Figma.

Proses kerja melibatkan kolaborasi intensif dengan pembimbing lapangan untuk memastikan desain yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan pengguna dan visi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pendampingan dilakukan melalui pertemuan rutin setiap minggu yang bertujuan untuk memberikan evaluasi, arahan, serta solusi terhadap permasalahan yang ditemukan selama pengerjaan proyek.

Hasil dari kegiatan ini tidak hanya berupa prototipe desain UI/UX yang lebih modern dan fungsional, tetapi juga pengalaman nyata dalam memahami proses desain berbasis kebutuhan pengguna. Dalam satu bulan pelaksanaan, fokus kegiatan diarahkan pada analisis sistem SILOBA yang berjalan, identifikasi kelemahan, dan peluang perbaikan desain. Kemudian, dilakukan pengembangan desain antarmuka yang *user-friendly* serta mendukung aksesibilitas bagi berbagai kalangan pengguna, terutama petugas kesehatan dan masyarakat umum.

Selain itu, pada tahap akhir PKL, dilakukan evaluasi desain bersama tim dari Dinas Kesehatan untuk mendapatkan umpan balik yang menjadi dasar penyempurnaan lebih lanjut. Dengan pendekatan berbasis studi kasus dan kolaborasi, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam mengembangkan keterampilan perancangan UI/UX, manajemen waktu, serta komunikasi profesional.

3.3.1. *Log Activity*

Tabel 3.1 Logbook Kegiatan

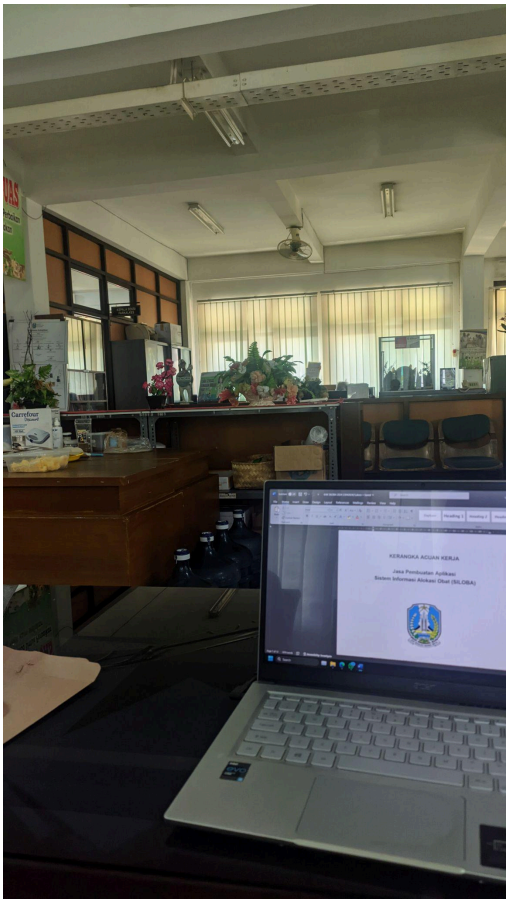
MINGGU KE	Kegiatan	Dokumentasi
1 (08 - 12 Juli 2024)	Pada minggu pertama, kegiatan diawali dengan pengenalan lingkungan kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Peserta PKL dibagi ke dalam beberapa divisi kerja, disertai penjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, struktur organisasi dan alur komunikasi di	

MINGGU KE	Kegiatan	Dokumentasi
	dinas juga dipelajari untuk mendukung kelancaran kegiatan. Salah satu agenda utama adalah diskusi awal terkait proyek pembaruan desain website SILOBA, yang menjadi fokus utama selama program magang.	
2 (15 - 19 Juli 2024)	Pada minggu kedua, kegiatan difokuskan pada tahap analisis kebutuhan pengguna dan admin untuk pembaruan website SILOBA. Tim mengumpulkan masukan langsung dari pengguna akhir, yaitu Dinas Kesehatan di tingkat kota dan kabupaten, terkait pengalaman mereka dalam menggunakan website. Beberapa masukan yang diperoleh mencakup kesulitan	

MINGGU KE	Kegiatan	Dokumentasi
	navigasi, kebutuhan akan fitur pelaporan yang lebih terstruktur, serta penambahan fitur notifikasi untuk memberi tahu jika permintaan atau permohonan obat telah disetujui. Dari sisi admin, ditemukan kebutuhan akan sistem pengelolaan data yang lebih efisien, dashboard yang mudah digunakan, serta kemampuan untuk menghasilkan laporan secara otomatis. Selain itu, peserta PKL turut diajak menghadiri salah satu program acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini memberikan wawasan langsung mengenai dunia kerja di sektor kesehatan, khususnya terkait dinamika	

MINGGU KE	Kegiatan	Dokumentasi
	kolaborasi antar-divisi dan pengelolaan program kesehatan. Pengalaman ini menjadi momen penting untuk memahami kebutuhan pengguna dalam konteks kerja mereka sehari-hari.	
3 (22 - 26 Juli 2024)	Pada minggu ketiga, tim berhasil menyelesaikan pembaruan desain UI/UX untuk website SILOBA. Desain baru ini dikembangkan dengan mengacu pada struktur website SILOBA yang lama, namun dengan berbagai perbaikan dan pembaruan berdasarkan masukan dari analisis sebelumnya. Setelah desain selesai, tim melakukan sesi bimbingan dengan mentor di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk	

MINGGU KE	Kegiatan	Dokumentasi
	mendapatkan masukan dan arahan lebih lanjut. Dalam diskusi tersebut, mentor kami yang juga merupakan admin SILOBA memberikan apresiasi terhadap desain yang telah dibuat dan menyampaikan beberapa saran perbaikan. Mentor juga menginformasikan rencana penambahan fitur baru yang sebelumnya belum tersedia di website SILOBA lama.	

MINGGU KE	Kegiatan	Dokumentasi
4 (29 Juli - 02 Agustus 2024)	Pada minggu keempat, tim melanjutkan revisi-revisi terhadap desain website SILOBA yang telah disetujui pada minggu sebelumnya. Revisi tersebut berdasarkan masukan yang diberikan oleh mentor kami, yang juga merupakan admin SILOBA. Selain itu, kami juga mulai mengintegrasikan tambahan fitur yang direncanakan ke dalam desain. Semua revisi dan tambahan fitur dilakukan di ruang kerja yang telah disediakan, dengan fokus untuk memastikan desain akhir memenuhi kebutuhan pengguna dan standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proses revisi ini melibatkan diskusi	

MINGGU KE	Kegiatan	Dokumentasi
	berkelanjutan dengan mentor untuk memastikan setiap perubahan sesuai dengan visi proyek dan memberikan dampak positif terhadap fungsionalitas website. Tim berusaha memastikan desain yang dihasilkan akan mudah diimplementasikan dan dapat digunakan dengan efisien oleh Dinas Kesehatan di tingkat kota dan kabupaten.	

MINGGU KE	Kegiatan	Dokumentasi
5 (05 - 08 Agustus 2024)	Pada minggu kelima, tim fokus melanjutkan tambahan-tambahan desain yang diperlukan untuk website SILOBA dan menyelesaikan berkas-berkas yang diperlukan untuk laporan PKL. Desain yang telah direvisi dan dilengkapi dengan fitur tambahan terus disempurnakan agar siap untuk dipresentasikan dan diimplementasikan. Selain itu, kami juga memastikan semua dokumentasi terkait dengan kegiatan PKL dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, kami menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yaitu Invasi Skrining	

MINGGU KE	Kegiatan	Dokumentasi
	Mandiri Gejala TBC dengan E-TIBI. Acara ini dihadiri oleh peserta PKL dari berbagai universitas, termasuk kami, serta mahasiswa dari universitas lain. Acara tersebut memberikan wawasan lebih dalam tentang upaya Dinas Kesehatan dalam menangani masalah TBC, serta bagaimana teknologi, dalam hal ini aplikasi E-TIBI, digunakan untuk mempermudah masyarakat melakukan skrining mandiri terhadap gejala TBC.	

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Hasil dari proyek ini merupakan sebuah rancangan desain untuk website SILOBA yang menyediakan sistem informasi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan data kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Rencananya, website ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dengan fitur yang lengkap, sistem navigasi yang praktis, aksesibilitas yang baik, dan penyajian informasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Perancangan ekspektasi terpenuhi. Pengujian dan iterasi yang dilakukan berulang kali membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sejak dini, sehingga menghasilkan desain yang *user-friendly* dan efektif. Selain itu, proyek ini juga menghasilkan beberapa komponen desain penting yang dapat dijadikan acuan untuk implementasi UI/UX berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setiap tahap perancangan, mulai dari penelitian hingga implementasi, dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan dan entasi website SILOBA meliputi,

4.1.1. Desain Halaman Login

Halaman ini dirancang untuk memastikan keamanan akses ke dalam sistem. Tampilan yang sederhana dan minimalis memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memasukkan kredensial mereka, dengan opsi tambahan seperti "Lupa Password" untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan masuk.

4.1.2. Desain Dashboard Utama

Dashboard utama menampilkan informasi penting seperti statistik kesehatan, status pengelolaan data, dan menu navigasi utama. Struktur tata

letak dibuat sedemikian rupa sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan dan mengakses fitur yang mereka butuhkan.

4.1.3. Desain Halaman Alokasi Obat

Halaman ini menyediakan sistem pengelolaan alokasi obat, baik berdasarkan program tahunan maupun program khusus lainnya. Pengguna dapat dengan mudah melihat daftar alokasi obat, jumlah ketersediaan, dan melakukan penyegaran data menggunakan tombol "*Refresh*" untuk memastikan informasi selalu terkini.

4.1.4. Desain Halaman Permintaan Obat

Halaman ini dilengkapi dengan kolom untuk mengisi informasi nama penanggung jawab, NIP, dan detail obat yang diminta, serta surat pengantar yang dapat diunggah. Desain ini dirancang untuk memastikan kelengkapan data dan mempercepat proses permintaan obat.

4.1.5. Pengoptimalan Navigasi dan Aksesibilitas

Sistem navigasi yang intuitif diterapkan untuk mempermudah pengguna dalam berpindah antar halaman. Fitur aksesibilitas, seperti penggunaan warna kontras tinggi dan tipografi yang jelas, juga ditambahkan untuk mendukung pengguna dengan berbagai kebutuhan.

4.1.6. Prototipe Figma

Semua desain yang telah dibuat dikompilasi dalam bentuk prototipe Figma. Prototipe ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik secara langsung sebelum pengembangan lebih lanjut dilakukan.

Dengan keberhasilan dalam menghasilkan rancangan ini, website SILOBA diharapkan mampu menjadi platform yang andal untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan data kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Semua desain telah disusun untuk memastikan

bahwa website tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga siap untuk disesuaikan dengan kebutuhan di masa depan.

4.2. Desain Sebelum Pembaruan

Berikut Merupakan tampilan desain awal SILOBA sebelum dilakukan pembaruan:

4.2.1. Halaman Awal



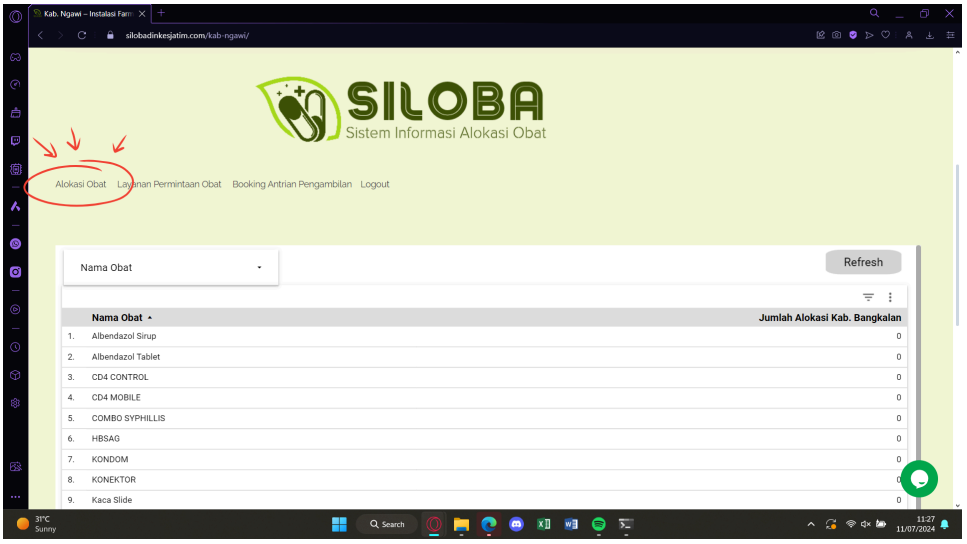
Gambar 4.1 Halaman Awal Sebelum Pembaruan

4.2.2. Halaman Login



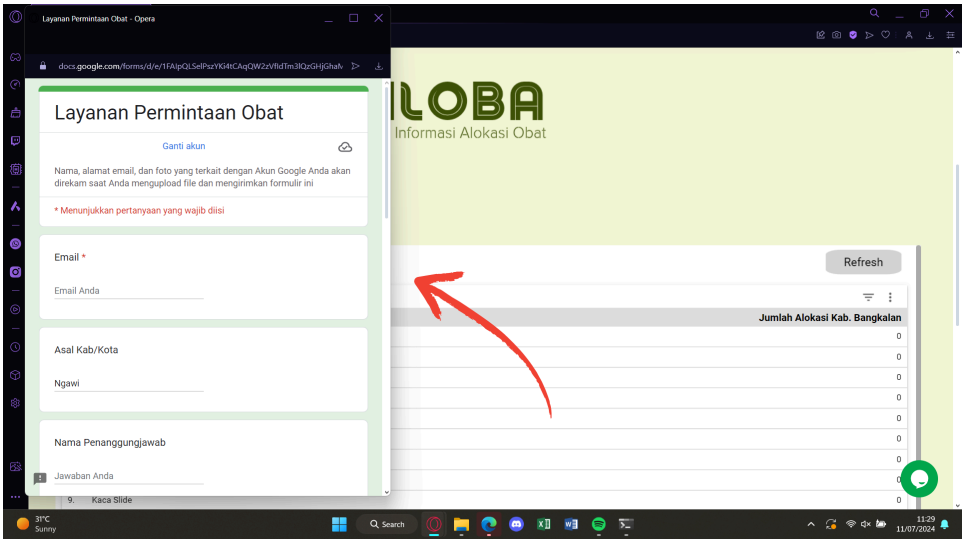
Gambar 4.2 Halaman Login Sebelum Pembaruan

4.2.3. Halaman Menu Alokasi Obat



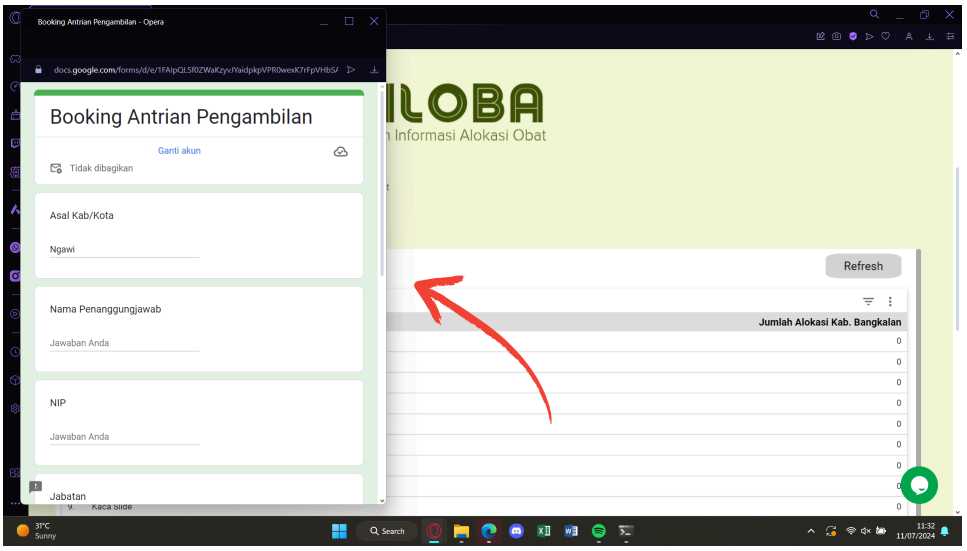
Gambar 4.3 Halaman Alokasi Obat Sebelum Pembaruan

4.2.4. Halaman Layanan Permintaan Obat



Gambar 4.4 Halaman Permintaan Obat Sebelum Pembaruan

4.2.5. Halaman Booking Antrian Pengambilan

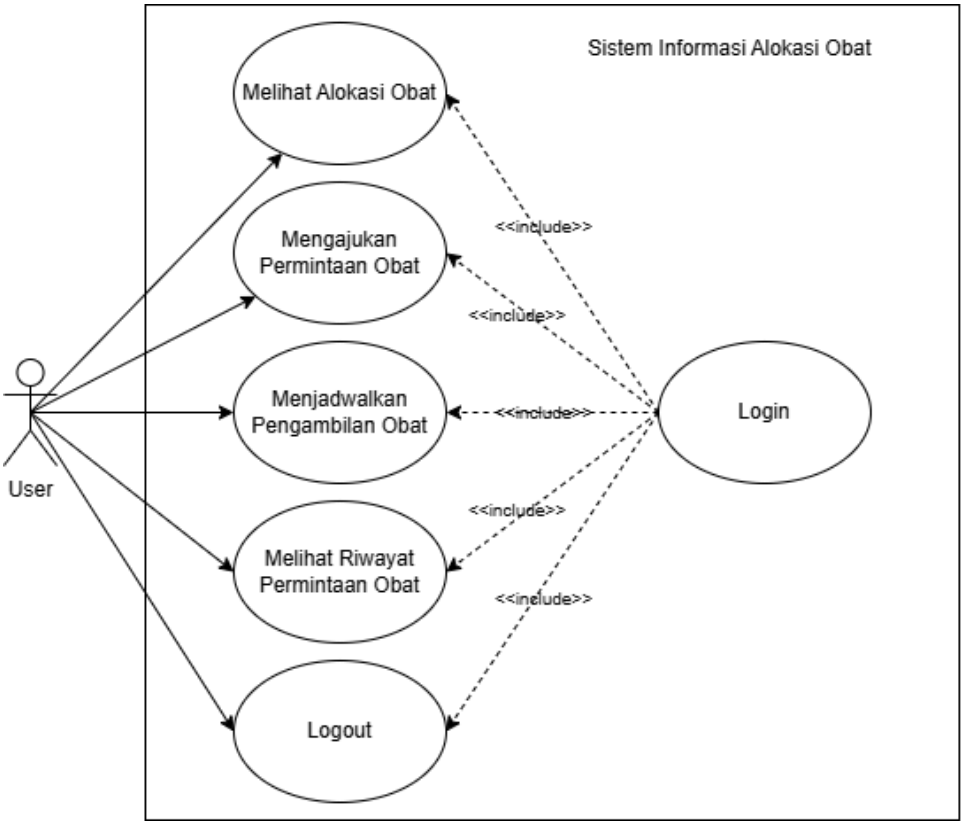


Gambar 4.5 Halaman Booking Antrian Pengambilan Sebelum Pembaruan

4.3. *Use Case Diagram*

Langkah awal dalam proses pengembangan aplikasi SILOBA adalah pembuatan *use case diagram* untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam penggunaan aplikasi, serta menyesuaikan kebutuhan aktor terhadap sistem yang di mana pada aplikasi SILOBA, aktor yang terlibat adalah pengguna (*user*) dan admin. Berikut adalah *use case diagram* yang dibuat untuk pengembangan aplikasi SILOBA:

4.3.1. *Use Case Diagram* untuk Pengguna (*User*)



Gambar 4.6 *Use Case Diagram* Pengguna

Use case diagram pada Gambar 4.6 menjelaskan secara rinci tentang interaksi antara aktor, yakni pengguna (*user*), dengan sistem yang terdapat pada aplikasi SILOBA. Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan berbagai skenario penggunaan aplikasi dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Berikut adalah penjelasan dari tiap komponen yang tercakup dalam diagram tersebut, yang meliputi berbagai aktor, kasus penggunaan, serta hubungan antar elemen-elemen tersebut dalam konteks aplikasi:

1. **Aktor (*User*):** Merupakan pengguna dari sistem SILOBA, yakni petugas yang mengelola obat-obatan di fasilitas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Berikut fitur yang dapat diakses oleh *user*:

a. **Melihat Alokasi Obat:** Fitur yang memungkinkan user melihat alokasi obat yang tersedia di fasilitas kesehatan mereka.

b. **Mengajukan Permintaan Obat:** Proses di mana user dapat mengajukan permintaan untuk kebutuhan obat tambahan. Fitur ini melibatkan pengisian formulir permintaan obat secara digital.

c. **Menjadwalkan Pengambilan Obat:** User dapat menentukan jadwal pengambilan obat yang telah disetujui untuk mempermudah proses logistik.

d. **Melihat Riwayat Permintaan Obat:** User dapat mengakses riwayat dari semua permintaan obat yang pernah diajukan, termasuk status persetujuan dan pengambilan.

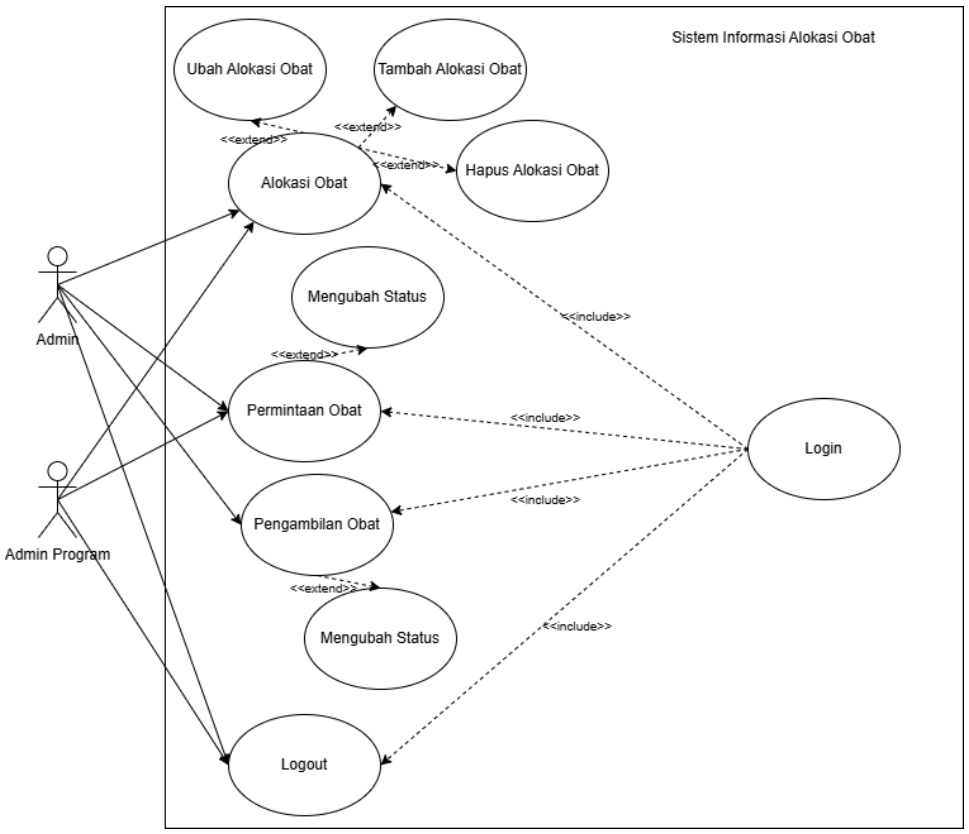
e. ***Login*:** Use case ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum user dapat mengakses fitur-fitur lain dalam sistem SILOBA.

f. ***Logout*:** User dapat keluar dari akun mereka setelah selesai menggunakan aplikasi.

2. **Hubungan:**

a. ***Include* (<>):** Setiap aktivitas seperti "Melihat Alokasi Obat","Mengajukan Permintaan Obat", "Menjadwalkan Pengambilan Obat", dan "Melihat Riwayat Permintaan Obat" memerlukan user untuk login terlebih dahulu.

4.3.2. *Use Case Diagram* untuk Admin



Gambar 4.7 *Use Case Diagram* Admin

Use case diagram pada Gambar 4.7 menjelaskan interaksi antara aktor yakni Admin dengan sistem yang terdapat pada website SILOBA. Berikut adalah penjelasan dari tiap komponen dalam diagram tersebut:

1. **Aktor (Admin):** Merupakan pengguna dari sistem SILOBA yang memiliki hak akses administrator. Aktor ini bertanggung jawab untuk mengelola data alokasi obat dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, serta menangani masalah yang muncul terkait dengan operasional sistem. Berikut fitur yang dapat diakses oleh admin:

    a. **Sistem Informasi Alokasi Obat:** Fitur utama yang memungkinkan admin untuk mengelola data alokasi obat dalam sistem.

b. **Ubah Alokasi Obat:** Proses di mana admin dapat mengubah data alokasi obat yang ada dalam sistem. (*Extend* dari Sistem Informasi Alokasi Obat)

c. **Tambah Alokasi Obat:** Proses di mana admin dapat menambahkan data alokasi obat baru ke dalam sistem. (*Extend* dari Sistem Informasi Alokasi Obat)

d. **Hapus Alokasi Obat:** Proses di mana admin dapat menghapus data alokasi obat yang sudah tidak relevan. (*Extend* dari Sistem Informasi Alokasi Obat)

e. **Mengubah Status:** Proses yang memungkinkan admin untuk memperbarui status alokasi obat, seperti status pengiriman atau penerimaan. (*Extend* dari Sistem Informasi Alokasi Obat)

f. ***Login*****:** *Use case* ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum admin dapat mengakses fitur-fitur lain dalam sistem SILOBA.

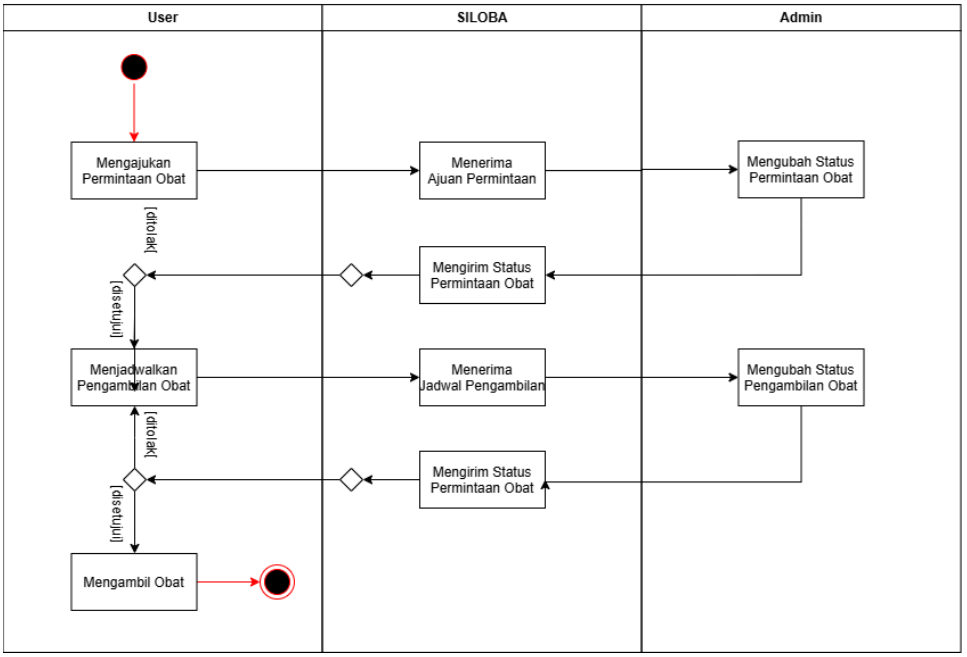
g. ***Logout*****:** Admin dapat keluar dari akun mereka setelah selesai menggunakan aplikasi.

2. **Hubungan:**

a. ***Include*** **(<>):** Setiap aktivitas seperti "Ubah Alokasi Obat", "Tambah Alokasi Obat", "Hapus Alokasi Obat", dan "Mengubah Status" memerlukan admin untuk login terlebih dahulu.

b. ***Extend*** **(<>):** Hubungan extend menunjukkan bahwa fitur "Ubah Alokasi Obat", "Tambah Alokasi Obat", "Hapus Alokasi Obat", dan "Mengubah Status" merupakan perluasan dari fitur "Sistem Informasi Alokasi Obat".

4.3.3. *Activity Diagram*



Gambar 4.8 *Activity Diagram*

Diagram aktivitas ini mengilustrasikan langkah-langkah yang diambil oleh pengguna kabupaten/kota dalam proses pengajuan permintaan dan pengambilan obat melalui sistem alokasi obat pada website SILOBA.

4.4. Hasil Desain Dan Alur Proses Penggunaan

Dalam proses pembuatan desain menggunakan Figma, tim memilih aplikasi ini karena keunggulannya dalam menyediakan fitur yang lengkap, fleksibel, dan mendukung kolaborasi *real-time*. Figma memungkinkan tim menggunakan berbagai *tools* seperti *Frame*, *Rectangle*, *Circle*, *Line*, serta kemampuan untuk menambahkan teks dan elemen lain dengan mudah.

Proses desain dimulai dengan menentukan konsep tata letak antarmuka pengguna langsung di Figma. Tim merancang setiap halaman dengan menambahkan elemen-elemen dasar seperti navigasi, tombol, dan elemen interaktif lainnya. Figma memudahkan proses ini melalui fitur *drag-and-drop* dan pengaturan *grid* untuk menjaga konsistensi desain.

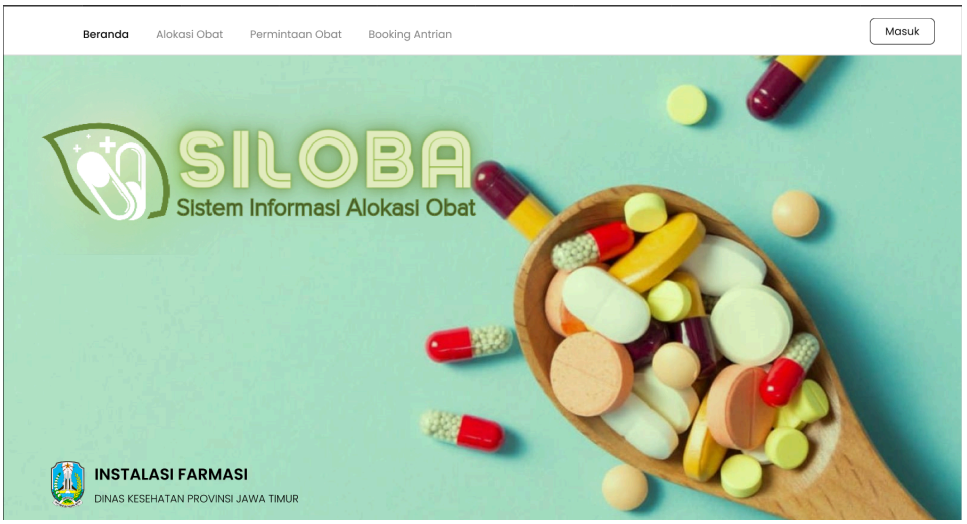
Setelah tata letak awal selesai, tim melanjutkan dengan menerapkan elemen visual seperti warna, tipografi, ikon, dan gambar. Desain dibuat dengan mempertimbangkan prinsip *user-centered design*, memastikan setiap elemen memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung alur kerja yang intuitif. Proses ini dilakukan secara iteratif dengan menambahkan dan menyesuaikan elemen berdasarkan masukan dari tim atau pengguna uji.

Setiap iterasi desain diuji untuk memastikan tata letak, navigasi, dan elemen interaktif berfungsi dengan baik. Feedback yang diterima digunakan untuk memperbaiki desain hingga mencapai hasil yang optimal. Figma mendukung proses ini dengan fitur prototyping, memungkinkan tim untuk membuat simulasi antarmuka secara langsung dan mengevaluasi pengalaman pengguna.

Setelah desain selesai, hasilnya dipresentasikan kepada stakeholders untuk mendapatkan validasi akhir. Melalui penggunaan Figma, tim berhasil menciptakan desain antarmuka yang menarik, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keunggulan Figma dalam mempermudah kolaborasi dan iterasi desain menjadikannya alat yang ideal untuk menghasilkan desain berkualitas tinggi.

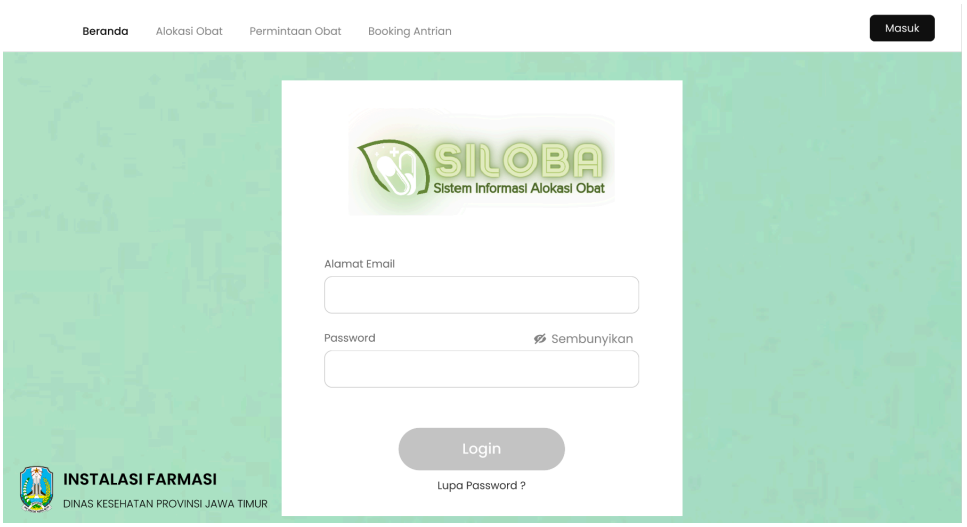
Alur proses penggunaan aplikasi SILOBA oleh pengguna (baik pengguna umum maupun admin) dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.6. Halaman Awal



Gambar 4.9 Tampilan Figma Halaman Awal

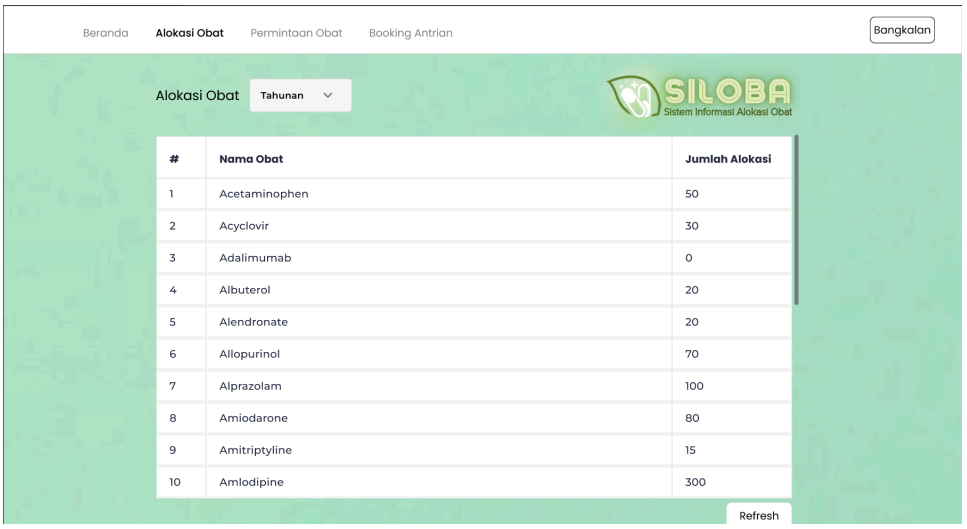
Pada Gambar 4.9, terdapat tampilan halaman utama aplikasi dengan desain awal sederhana. Di bagian atas, terdapat area yang didedikasikan untuk logo aplikasi, di mana *placeholder* digunakan untuk menggambarkan posisi elemen tersebut. Logo ini akan berfungsi sebagai identitas visual aplikasi. Di bawahnya, terdapat judul utama yang menyoroti fungsi aplikasi sebagai sistem informasi yang terintegrasi. Judul ini ditempatkan secara strategis untuk menarik perhatian pengguna saat pertama kali membuka aplikasi. Di bagian atas kanan halaman, terdapat tombol bertuliskan "*Login*". Tombol ini dirancang dengan ukuran yang menonjol dan warna kontras agar mudah terlihat dan digunakan oleh pengguna. Fungsi tombol "*Login*" adalah untuk memberikan akses bagi pengguna yang sudah memiliki akun ke dalam sistem. Penempatan tombol yang sederhana namun intuitif ini memastikan pengguna dapat dengan cepat memulai interaksi dengan aplikasi tanpa kebingungan. Desain halaman utama ini memberikan fokus utama pada aksesibilitas dan kemudahan penggunaan, dengan tata letak yang bersih dan elemen yang langsung menjelaskan tujuan aplikasi.



Gambar 4.10 Tampilan Figma Halaman *Login*

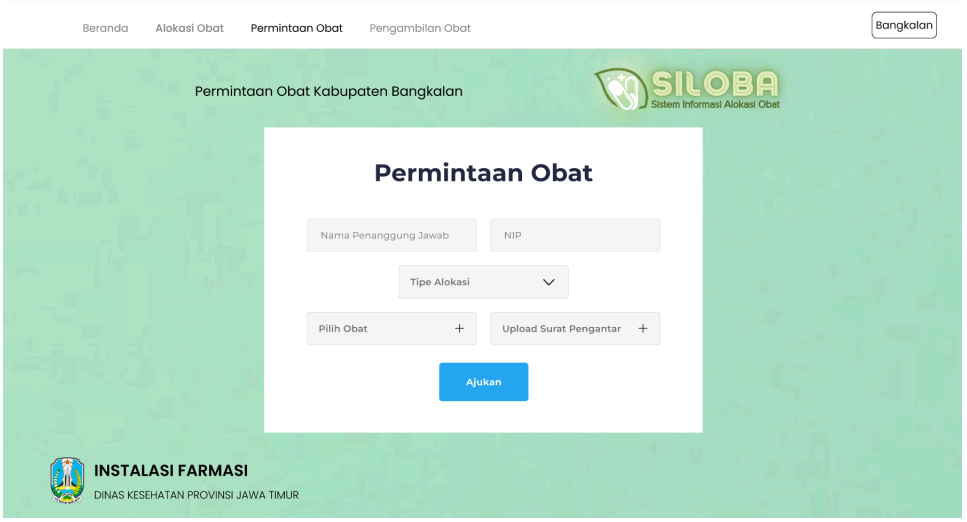
Pada Gambar 4.10, terdapat tampilan halaman untuk *Login* pada desain, di mana terdapat dua kolom input utama. Kolom input pertama digunakan untuk memasukkan email yang terdaftar pada akun pengguna, sedangkan kolom input kedua digunakan untuk memasukkan password akun pengguna. Di bawah kolom *input*, terdapat tombol "*Login*" yang dirancang untuk memberikan akses ke dalam sistem setelah pengguna memasukkan *email* dan kata sandi dengan benar. Tombol ini dibuat dengan ukuran yang cukup besar dan warna yang kontras untuk memastikan mudah ditemukan dan digunakan oleh pengguna. Selain itu, untuk mengakomodasi pengguna yang mungkin lupa kata sandi akun mereka, terdapat opsi tambahan berupa tautan "Lupa Password?" di bawah kolom input. Relasi Halaman: Halaman Login → Dashboard *User* atau Dashboard Admin.

4.2.7. Halaman *User*



Gambar 4.11 Tampilan Figma Halaman Alokasi Obat

Pada Gambar 4.11, terdapat tampilan halaman Alokasi Obat pada desain aplikasi, yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi mengenai alokasi obat secara rinci. Di bagian atas halaman, terdapat judul besar bertuliskan "Alokasi Obat" yang menunjukkan fungsi halaman ini. Di sampingnya, terdapat opsi untuk menyaring alokasi obat berdasarkan tahun atau program. Pengguna dapat memilih salah satu *filter* tersebut untuk menampilkan data alokasi obat yang relevan sesuai kebutuhan. Setelah *filter* dipilih, sistem akan menampilkan daftar alokasi obat yang mencakup informasi seperti nama obat dan jumlahnya. Selain itu, di bagian bawah halaman terdapat tombol *Refresh* yang memungkinkan pengguna untuk memperbarui data alokasi obat secara manual. Tombol ini berguna untuk memastikan informasi yang ditampilkan selalu *up-to-date* dengan data terbaru dari sistem. Relasi Halaman: Dashboard User → Halaman Alokasi Obat.



Gambar 4.12 Tampilan Figma Halaman Permintaan Obat

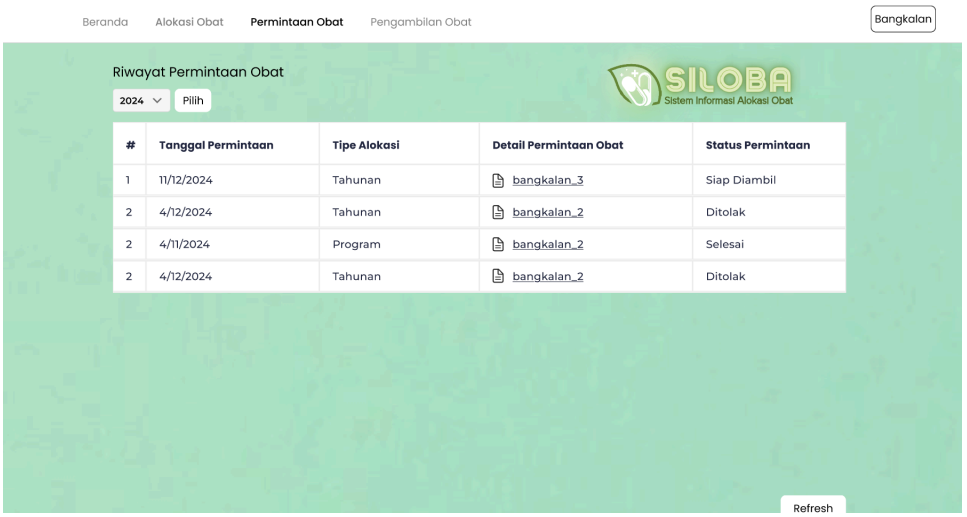
Pada Gambar 4.12, terdapat tampilan halaman “Permintaan Obat” pada desain aplikasi, yang dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam mengajukan permintaan obat. Di bagian atas halaman, terdapat judul besar bertuliskan "Permintaan Obat" untuk memberikan identitas yang jelas mengenai fungsi halaman ini. Di bawah judul, terdapat beberapa kolom input yang harus diisi oleh pengguna, antara lain:

1. Nama Penanggung Jawab: Kolom ini digunakan untuk memasukkan nama lengkap penanggung jawab yang mengajukan permintaan obat.

2. NIP (Nomor Induk Pegawai): Kolom ini diisi dengan nomor induk pegawai dari penanggung jawab sebagai identitas resmi.

Setelah informasi penanggung jawab diisi, pengguna dapat memilih opsi Alokasi Obat berdasarkan tahunan atau program melalui dropdown menu. Filter ini memastikan bahwa permintaan obat sesuai dengan alokasi yang tersedia. Di bagian berikutnya, dapat memilih detail obat. Di samping detail obat, terdapat opsi untuk mengunggah Surat Pengantar. Pengguna dapat mengunggah dokumen dalam format yang sesuai PDF dengan tombol "*Upload* Surat Pengantar" yang tersedia. Halaman ini juga menyediakan tombol Kirim Permintaan di bagian bawah untuk

mengirimkan permintaan obat ke sistem. Relasi Halaman: Dashboard *User* → Halaman Permintaan Obat → Riwayat Permintaan.



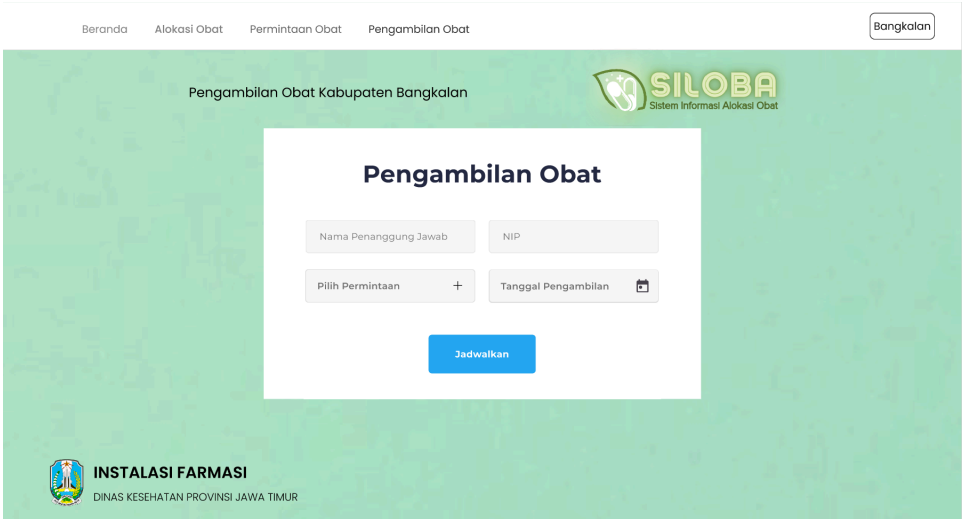
Gambar 4.14 Tampilan Figma Halaman Riwayat Permintaan Obat

Pada Gambar 4.14, terdapat tampilan halaman yang dirancang untuk menampilkan riwayat permintaan obat yang telah dilakukan oleh pengguna. Halaman ini berisi daftar permintaan obat dengan rincian detail yang dapat dilihat untuk setiap permintaan yang telah diajukan. Setiap item dalam daftar riwayat permintaan mencakup informasi seperti:

1. Tanggal Permintaan: Waktu permintaan diajukan.
2. Tipe Alokasi Obat: Tahunan dan Program
3. Detail Permintaan Obat: Obat apa saja yang dipesan
4. Status Permintaan: Status terkini, seperti "Diproses", "Siap Diambil", atau "Ditolak".

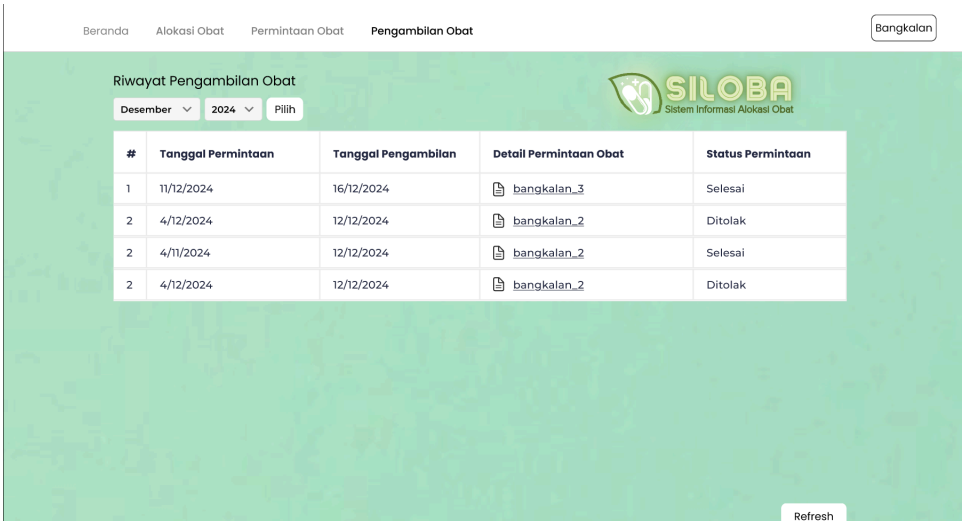
Saat pengguna memilih salah satu item dari daftar, detail permintaan obat akan ditampilkan dalam kotak yang lebih besar dengan label "Detail Permintaan Obat". Kotak ini berisi informasi lebih lengkap, seperti “Detail

Obat" yaitu daftar obat yang diminta beserta jumlahnya. Relasi Halaman: Halaman Permintaan Obat → Riwayat Permintaan → Status Diperbarui.



Gambar 4.13 Tampilan Figma Halaman Pengambilan Obat

Pada Gambar 4.13, terdapat tampilan halaman untuk mencari sertifikasi yang tersedia, yang di mana di bagian atas layar, judul "Semua Sertifikasi" menunjukkan bahwa halaman ini digunakan untuk menampilkan semua sertifikasi yang tersedia dalam aplikasi. Lalu, di bawah judul, terdapat sebuah kolom pencarian yang diberi label "Cari sertifikasi". Kolom ini memungkinkan pengguna untuk mencari sertifikasi tertentu dengan memasukkan kata kunci terkait. Setelah itu, di bawah kolom pencarian, terdapat beberapa kotak berwarna abu-abu yang masing-masing berisi teks *placeholder* "Nama Sertifikasi". Setiap kotak ini merepresentasikan sertifikasi yang tersedia. Relasi Halaman: Riwayat Permintaan Obat → Pengambilan Obat → Riwayat Pengambilan Obat.



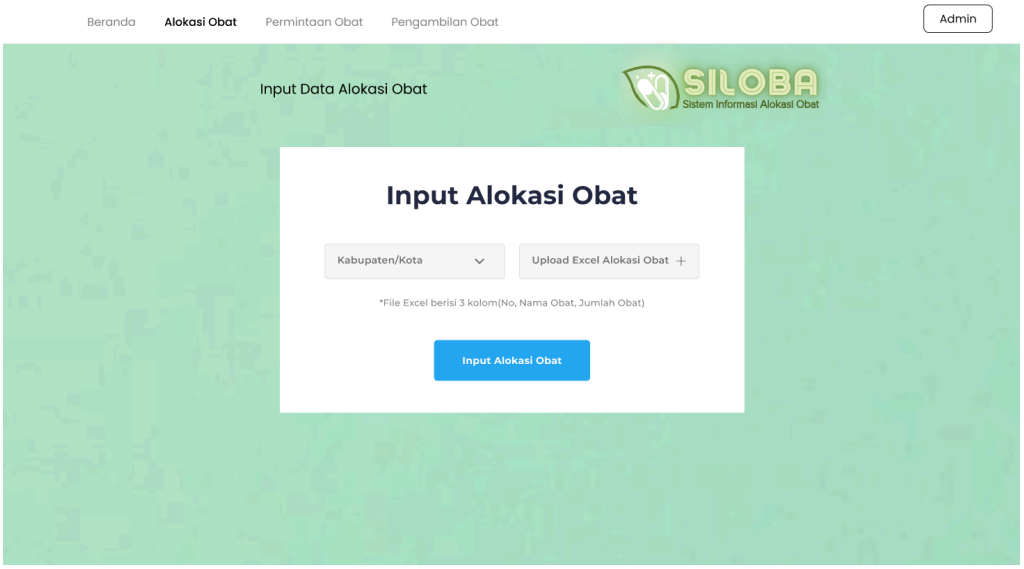
Gambar 4.15 Tampilan Figma Halaman Riwayat Pengambilan Obat

Pada Gambar 4.15, terdapat tampilan halaman yang dirancang untuk menampilkan riwayat pengambilan obat oleh pengguna. Halaman ini menyediakan informasi detail terkait setiap permintaan obat yang telah diajukan dan status pengambilannya. Setiap entri dalam daftar riwayat pengambilan mencakup:

1. Tanggal Permintaan: Tanggal saat permintaan obat diajukan.
2. Tanggal Pengambilan: Tanggal obat diambil oleh pemohon.
3. Detail Permintaan: Ringkasan detail obat yang diminta, termasuk nama obat dan jumlahnya.
4. Status: Status terkini dari pengambilan obat, seperti "Belum Diambil", "Selesai", atau "Ditolak".

Relasi Halaman: Halaman Pengambilan Obat → Riwayat Pengambilan Obat.

4.2.8. Halaman Admin



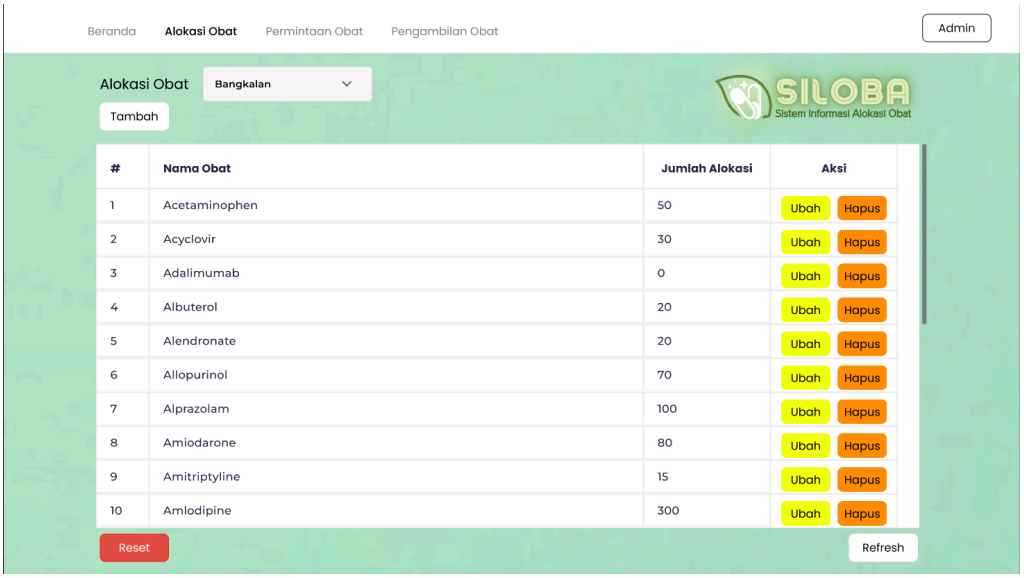
Gambar 4.16 Tampilan Figma Halaman Input Alokasi Obat

Pada Gambar 4.16, ditampilkan halaman Input Alokasi Obat yang dirancang khusus untuk admin. Halaman ini bertujuan untuk memudahkan admin dalam mengelola data alokasi obat berdasarkan kabupaten/kota secara efisien. Berikut adalah elemen-elemen yang terdapat pada halaman ini:

1. Kabupaten/Kota: Dropdown atau kolom input yang memungkinkan admin memilih kabupaten atau kota tertentu sebagai lokasi target alokasi obat.

2. *Upload* Excel: Tombol atau area unggahan file yang memungkinkan admin untuk mengunggah file Excel berisi data alokasi obat. File ini dapat berisi informasi detail seperti jenis obat, jumlah, dan lokasi distribusi.

Relasi Halaman: Dashboard Admin → Input Alokasi Obat → Edit Alokasi Obat.



Gambar 4.17 Tampilan Figma Manajemen Alokasi Obat

Pada Gambar 4.17, ditampilkan halaman Manajemen Alokasi Obat yang dirancang untuk admin dalam mengelola data alokasi obat secara lebih detail. Halaman ini memungkinkan admin untuk melakukan berbagai tindakan terkait alokasi obat di kabupaten atau kota yang dipilih. Berikut adalah fitur-fitur utama yang terdapat pada halaman ini:

1. Pilih Kota/Kabupaten: *Dropdown* atau kolom input yang memungkinkan admin memilih kabupaten atau kota tertentu untuk melihat dan mengelola data alokasi obat yang tersedia.

2. Tambah Obat: Tombol untuk menambahkan jenis obat baru ke dalam alokasi kota/kabupaten yang dipilih. Admin dapat mengisi nama obat, jumlah alokasi, dan informasi terkait lainnya.

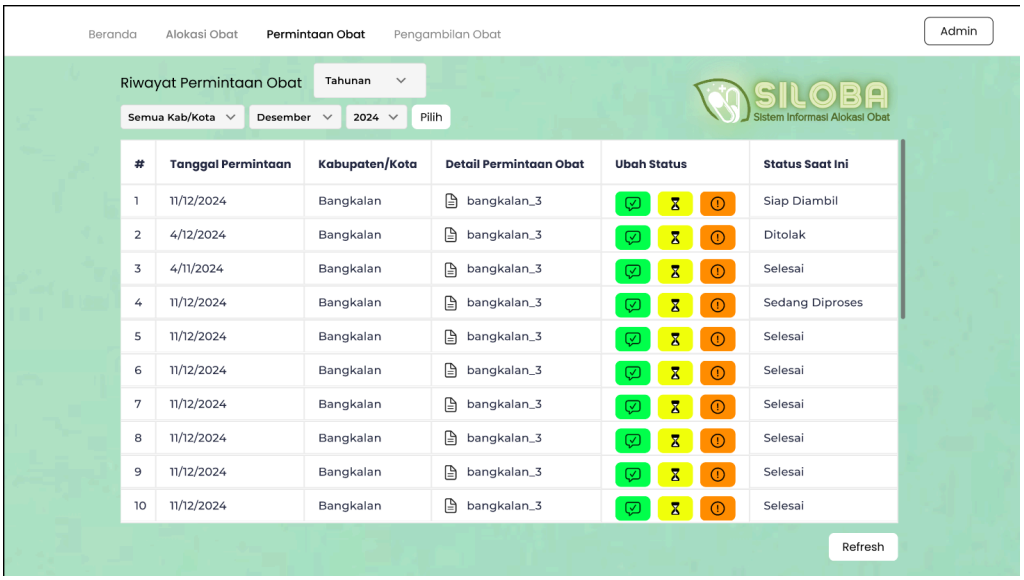
3. Ubah Jumlah: Tombol untuk mengedit jumlah alokasi obat yang sudah ada. Fitur ini mempermudah admin dalam melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan distribusi.

4. Hapus Obat: Tombol untuk menghapus jenis obat tertentu dari daftar alokasi. Tindakan ini dilakukan jika obat tidak lagi diperlukan atau terdapat kesalahan input sebelumnya.

5. Reset Alokasi: Tombol untuk menghapus seluruh data alokasi obat pada kota/kabupaten yang dipilih, memungkinkan admin memulai pengelolaan data dari awal.

6. Refresh: Tombol untuk memperbarui tampilan data agar mencerminkan perubahan terbaru yang telah dilakukan.

Relasi Halaman: Input Alokasi Obat ←→ Edit Alokasi Obat.



Gambar 4.18 Tampilan Figma Riwayat Permintaan Obat

Pada Gambar 4.18, ditampilkan halaman Riwayat Permintaan Obat yang dirancang untuk admin agar dapat memantau dan mengelola riwayat permintaan obat dari kabupaten/kota tertentu. Halaman ini mencakup fitur-fitur berikut:

1. Filter Permintaan Obat:
   a. Obat Program/Tahunan: *Dropdown* atau *toggle* yang memungkinkan admin untuk memilih jenis obat yang akan ditampilkan berdasarkan kategori program atau tahunan.
   b. Kabupaten/Kota: *Dropdown* untuk memilih kabupaten/kota tertentu guna memfilter permintaan obat sesuai dengan wilayah yang diinginkan.

c. Bulan dan Tahun: Pilihan untuk menyaring permintaan berdasarkan periode tertentu, memudahkan admin dalam melihat riwayat secara lebih spesifik.

2. Tabel Riwayat Permintaan:

a. Tanggal Permintaan: Menunjukkan kapan permintaan obat diajukan.

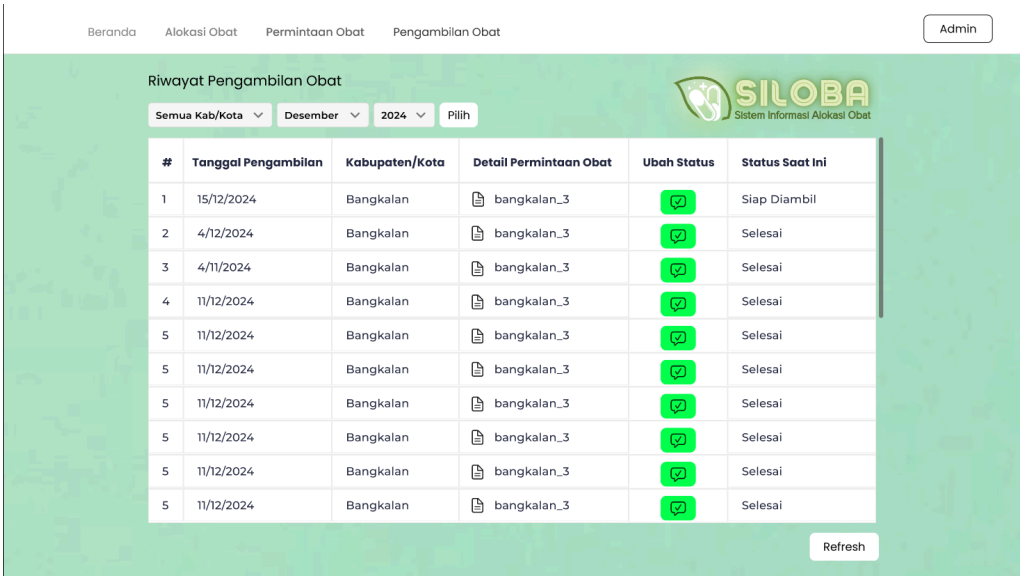
b. Kabupaten/Kota: Nama kabupaten atau kota yang mengajukan permintaan obat.

c. Detail Permintaan Obat: Tombol atau link untuk melihat rincian permintaan obat, termasuk jenis obat dan jumlah yang diajukan.

d. Ubah Status: Tombol untuk mengubah status permintaan, seperti "Sedang Diproses," "Selesai," atau "Ditolak." Fitur ini memudahkan admin untuk memperbarui informasi status permintaan secara langsung.

e. Status Saat Ini: Menampilkan status terkini dari setiap permintaan obat, memberikan gambaran cepat mengenai progres penanganan permintaan tersebut.

Relasi Halaman: Dashboard Admin → Riwayat Permintaan Obat → Riwayat Pengambilan Obat.



Gambar 4.19 Tampilan Figma Riwayat Pengambilan Obat

Pada Gambar 4.19, ditampilkan halaman Riwayat Pengambilan Obat yang dirancang untuk admin agar dapat memantau dan mengelola data pengambilan obat oleh kabupaten/kota. Halaman ini mencakup fitur-fitur berikut:

3. Filter Pengambilan Obat:
   a. Kabupaten/Kota: *Dropdown* untuk memilih kabupaten/kota tertentu guna memfilter data pengambilan obat sesuai wilayah yang diinginkan.
   b. Bulan dan Tahun: Pilihan untuk menyaring data pengambilan berdasarkan periode tertentu, mempermudah admin untuk melihat riwayat pengambilan secara lebih spesifik.
   c. Tabel Riwayat Pengambilan:
   d. Tanggal Pengambilan: Menunjukkan kapan obat diambil oleh kabupaten/kota.
   e. Kabupaten/Kota: Nama kabupaten atau kota yang mengambil obat.

f. Detail Permintaan Obat: Tombol atau link untuk melihat rincian permintaan obat terkait, termasuk jenis obat dan jumlah yang telah diambil.

g. Ubah Status: Tombol untuk mengubah status pengambilan obat, seperti "Selesai," "Selesai," atau "Dibatalkan." Fitur ini membantu admin dalam memperbarui informasi status pengambilan secara langsung.

h. Status Saat Ini: Menampilkan status terkini dari pengambilan obat, memberikan gambaran cepat mengenai progres pengambilan obat.

Relasi Halaman: Dashboard Admin → Riwayat Permintaan Obat → Riwayat Pengambilan Obat.

4.5. Pembahasan

Pembaruan desain UI/UX website SILOBA yang dikerjakan kelompok kami selama kegiatan PKL di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan harapan dapat membuat prototipe desain UI untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan tampilan sistem SILOBA karena dari tampilan UI sebelumnya masih terdapat bug dari peletakan tombol dan kami menambahkan beberapa fitur dari sistem sebelumnya yang belum ada dan juga berusaha meningkatkan pada desain tampilan.

Desain baru dirancang untuk mendukung tiga proses bisnis utama yaitu autentikasi pengguna, akses informasi kesehatan, dan pengelolaan data. Fitur-fitur seperti pengelolaan alokasi obat tahunan/program, detail obat, dan surat pengantar telah diintegrasikan untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas administratif.

Proses perancangan menggunakan metode iteratif yang melibatkan pembuatan sketsa awal, implementasi prototipe menggunakan Figma, serta konsultasi secara berkala terhadap desain yang kami kerjakan. Hasil dari Konsultasi yang kami lakukan sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah

sejak dini, seperti tata letak yang kurang responsif atau kurangnya fitur penting. Iterasi dilakukan secara berulang untuk memperbaiki masalah tersebut hingga menghasilkan desain akhir yang lebih optimal.

Kendala utama yang dihadapi selama proses ini adalah keterbatasan waktu dan data awal mengenai kebutuhan pengguna. Untuk mengatasi hal ini, diskusi intensif dilakukan dengan pembimbing lapangan dan stakeholder terkait, yang memberikan masukan berharga dalam merancang solusi desain yang sesuai. Selain itu, penggunaan *tools* seperti Figma memungkinkan tim untuk bekerja secara efisien dalam merancang prototipe dan melakukan perubahan dengan cepat berdasarkan umpan balik yang diterima.

Desain baru ini menawarkan beberapa inovasi dibandingkan versi sebelumnya. Misalnya, fitur navigasi diperbarui untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi, sementara elemen visual seperti warna, ikon, dan tata letak dirancang untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan. Selain itu, fitur alokasi obat dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk memilih opsi berdasarkan tahun atau program, yang sebelumnya tidak tersedia pada desain lama.

Dari hasil bimbingan dari pihak instansi beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut tetap diajukan, seperti integrasi sistem SILOBA dengan platform lain di Dinas Kesehatan dan penambahan fitur analitik untuk memantau penggunaan website secara lebih mendalam.

Secara keseluruhan, pembaruan desain UI/UX website SILOBA berhasil memperbarui rancangan desain terhadap upaya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam menyajikan informasi kesehatan yang lebih baik. Proyek ini tidak berhenti disini saja tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di masa depan.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam keseluruhan penyusunan laporan PKL ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan tersusunnya laporan ini, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung selama 1 bulan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

2. Kegiatan PKL ini berfokus pada perancangan desain antarmuka (UI) menggunakan Figma yang lebih sederhana dan efisien, sehingga meningkatkan kemudahan akses dan pengalaman pengguna pada website SILOBA. Desain ini dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna dan studi kasus sistem informasi kesehatan.

3. Optimalisasi dilakukan pada desain fitur-fitur yang ada di website SILOBA agar lebih otomatis dan mendukung proses pelayanan serta pengelolaan data kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proses ini mencakup analisis sistem, perancangan desain antarmuka, hingga evaluasi hasil implementasi dengan panduan dari pembimbing lapangan untuk memastikan keberhasilan.

5.2. Saran

Untuk mendukung keberlanjutan dan pengoptimalan desain UI/UX website SILOBA, disarankan agar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara rutin melakukan evaluasi terhadap desain dan fungsionalitas website guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Selain itu, pelatihan bagi staf yang bertugas dalam pengelolaan website perlu dilakukan untuk memastikan kemampuan mereka dalam memanfaatkan fitur-fitur baru secara maksimal. Di samping itu, penambahan fitur analitik dapat menjadi langkah strategis untuk memantau pola penggunaan website, sehingga informasi

tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengembangan fitur lebih lanjut. Integrasi website SILOBA dengan sistem informasi lain yang relevan juga perlu dipertimbangkan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terhubung dan efisien dalam mendukung pelayanan kesehatan. Terakhir, penting bagi Dinas Kesehatan untuk secara konsisten mengumpulkan umpan balik dari pengguna melalui survei atau forum diskusi, sehingga kelemahan pada desain maupun fungsionalitas dapat diidentifikasi dan ditingkatkan demi memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Hutauruk, M. K. (2019, November 26). *UML Diagram : Use Case Diagram*. SoCS Binus University. Retrieved Juni 24, 2024, from https://socs.binus.ac.id/2019/11/26/uml-diagram-use-case-diagram/

Jean Sundego, J. (2023, Juni 16). *Figma Adalah: Fitur, Kegunaan, dan Manfaatnya*. Purwadhika. Retrieved Juni 24, 2024, from https://purwadhika.com/blog/figma-adalah-fitur-kegunaan-dan-manfaatnya

Prasetyo, T. A. (2021, September 9). *High Fidelity Prototyping*. Medium. Retrieved Juni 23, 2024, from https://medium.com/product-21/high-fidelity-prototyping-e6cdcbdd3f52

Pratama, D. A. (2023, November 15). *Low-Fidelity vs High-Fidelity Prototyping*. Dicoding. Retrieved Juni 23, 2024, from https://www.dicoding.com/blog/low-fidelity-vs-high-fidelity-prototyping/

Susrama, I. G., Sampurno, I. A. W., & Sugiarto, S. (2020, September 13). SISTEM TERINTEGRASI UJI KOMPETENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI. *Jurnal Penelitian Politeknik Penerbangan Surabaya*, *5*(3), 181-191. https://ejournal.poltekbangsby.ac.id/index.php/jurnalpenelitian/article/download/503/436

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan







